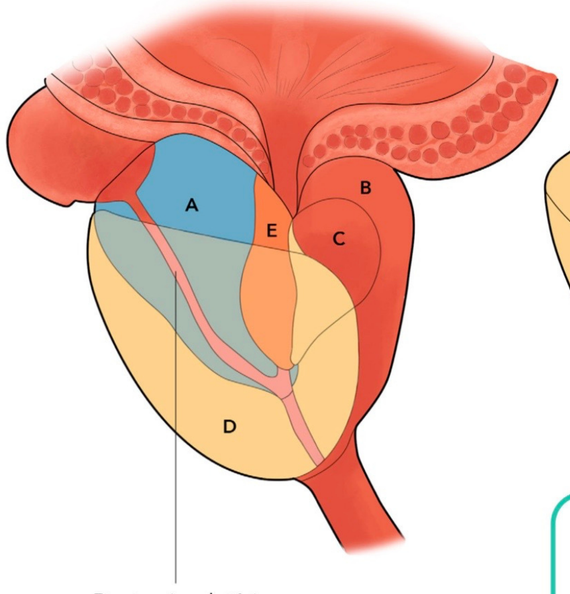
Urologia

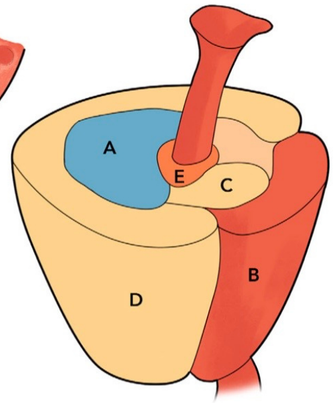
Cirurgia

Hiperplasia Prostática Benigna

HPB

ANATOMIA - ZONAS DA PRÓSTATA





A. Zona central
B. Zona fibromuscular
C. Zona de transição
D. Zona periférica
E. Zona periuretral

Zona de transição

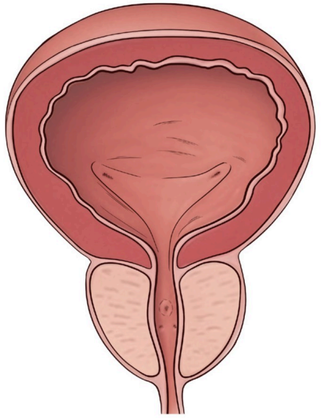
Região com maior relevância na HPB.

Zona periférica

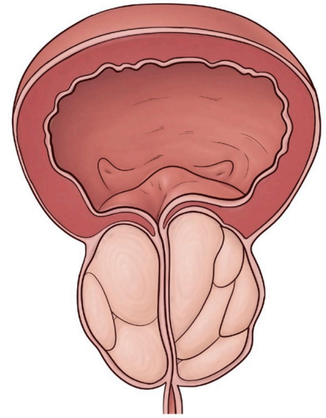
75% do tecido glandular encontra-se nessa região. Portanto, é a que mais se relaciona a câncer de próstata.

FISIOPATOLOGIA

- Processo regulado por hormônios androgênicos (principalmente DHT)
- Proliferação tecidual leva a:
  - Obstrução mecânica
  - Obstrução funcional
- Obstrução do fluxo urinário produz alterações vesicais (sintomas irritativos)



Próstata normal



Próstata com hiperplasia

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

HPB

Estratégia MED

APRESENTAÇÃO CLÍNICA (LUTS)

Sintomas obstrutivos	Sintomas irritativos
Jato urinário fraco	Urgência miccional
Intermitência urinária	Incontinência
Hesitação miccional	Noctúria
Gotejamento pós-miccional	Polaciúria
Incontinência paradoxal	Disúria
Esvaziamento vesical incompleto	

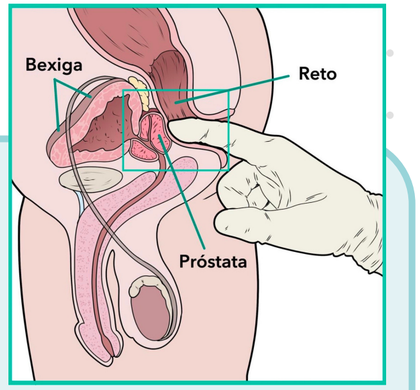
Retenção urinária aguda

- Clínica: paciente com histórico de LUTS que evolui de forma aguda com: impossibilidade de urinar, dor em hipogastro e distensão vesical
- Exame físico: globo vesical palpável.
- Tratamento: sondagem vesical + teste de micção espontânea.

EXAME FÍSICO

Toque retal

Deve ser realizado em TODOS os pacientes com sintomas de HPB!



	Próstata normal	Próstata com HPB
Consistência	Fibroelástica	Fibroelástica
Mobilidade	Próstata móvel	Próstata móvel
Superfície	Lisa, sem nodulações	Lisa, sem nodulações
Contorno	Regular e simétrico	Regular e simétrico
Tamanho	Semelhante a uma noz (~ 4,5 x 3,5 cm)	Aumentado
Sulco mediano	Preservado	Preservado

EXAMES COMPLEMENTARES

PSA	Urina 1	USG de rins e vias urinárias
Sabiston e AUA	Sabiston e AUA	AUA
Investigar câncer de próstata	Investigar hematúria e leucocitúria	Avaliar hidronefrose, divertículos vesicais e resíduos pós-miccionais.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

HPB

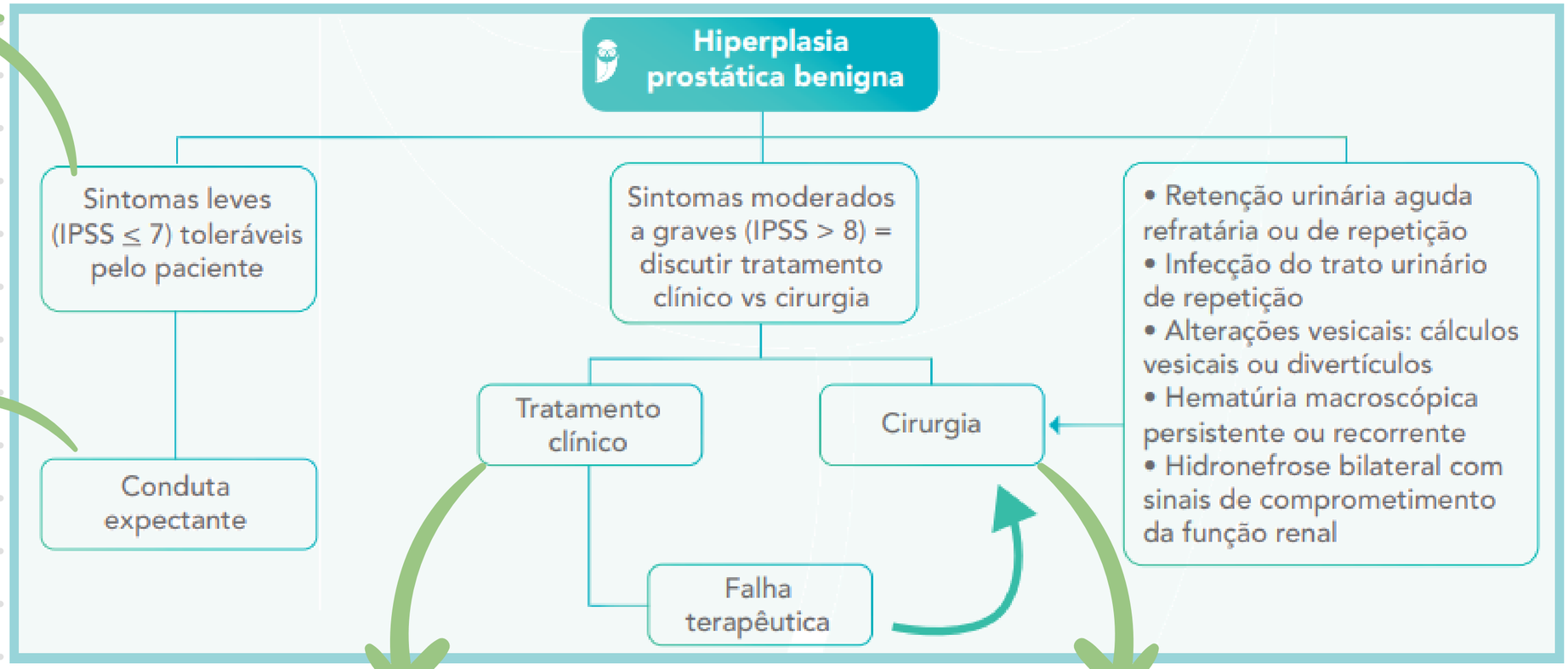
TRATAMENTO

Estratégia MED

<u>Escore de sintomas (IPSS)</u>:
É uma pontuação baseada em um questionário sobre os sintomas do paciente. Quanto maior é a pontuação, mais grave é o quadro.
- Sintomas leves (0 a 7 pts)
- Sintomas moderados (8 a 19 pts)
- Sintomas graves (20 a 35 pts)

Tem relevância para orientação terapêutica.

<u>Conduta expectante</u>:
- Micção na posição sentada
- Evitar líquidos antes de dormir ou sair
- Reduzir o consumo de alimentos diuréticos, como cafeína e álcool
- Forçar o esvaziamento vesical completo ao menos 2 vezes ao dia



<u>Tratamento medicamentoso</u>:

Classe	Representantes	Mecanismo de ação	Principais particularidades
Antagonistas alfa-1-adrenérgico	Doxazosina, Tansulosina, Alfazosina	Reduz o tônus da musculatura lisa prostática e do colo vesical	Tempo de ação curto. Terapia de escolha para monoterapia.
Inibidores da 5-alfa-redutase	Finasterida, Dutasterida	Bloqueia a conversão de testosterona em DHT	Efeito terapêutico ocorre após 6 meses a 1 ano. Reduz valores de PSA.
Agentes anticolinérgicos	Oxibutinina, Tolterodina	Diminui a hiperatividade do músculo detrusor	Útil no tratamento dos sintomas irritativos. Muitos efeitos colaterais.

<u>Estratégias terapêuticas cirúrgicas</u>:
- Próstata < 30g = ressecção transuteral (RTU) ou *laser*
- Próstata de 30 a 80g = RTU, *laser* ou prostatectomia subtotal
- Próstata > 80g = prostatectomia subtotal
- Qualquer tamanho com complicações (divertículo / litíase vesical) = prostatectomia subtotal

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Câncer de Próstata

CaP

EPIDEMIOLOGIA

- Neoplasia maligna visceral mais comum nos homens
- 90% das neoplasias malignas de próstata são adenocarcinomas
- Acomete principalmente a zona periférica
- Principal fator de risco: idade > 65 anos
- Outros fatores de risco:
  - Etnia (maior na população negra e menor na asiática)
  - História familiar
  - Dieta
  - Obesidade
  - História de prostatite
- NÃO são fatores de risco:
  - Hiperplasia prostática benigna
  - Tabagismo
  - Etilismo

APRESENTAÇÃO CLÍNICA

Na maioria das vezes é assintomático!

Doença localizada	Doença metastática
• Disúria • Hematúria • Retenção urinária • Incontinência urinária • Hematospermia • Disfunção erétil	• Dor óssea • Fraturas patológicas • Perda de peso e anemia • Paresia e/ou parestesia de membros inferiores (secundárias à compressão medular)

RASTREAMENTO

Toque retal e PSA anuais

Indicação:

Sociedade Brasileira de Urologia	Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde
Acima de 50 anos ou acima de 45 anos se negro ou familiar de 1º grau com câncer de próstata	Não recomendam rastreamento populacional de câncer de próstata

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CaP

FLUXOGRAMA DIAGNÓSTICO

Estratégia MED

PACIENTE SINTOMÁTICO OU RASTREIO POPULACIONAL

TOQUE RETAL ALTERADO | **E / OU** | **PSA ALTERADO**

TOQUE RETAL ALTERADO:
- Nódulos endurados
- Irregularidades da superfície prostática
- Assimetria prostática

AVALIAÇÃO DO ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA):

PSA < 4ng/mL	PSA 4-10	PSA > 10
Faixa de normalidade	Zona cinzenta	Altamente sugestivo da câncer

REFINAMENTO DO PSA:
- Densidade -> alterado: > 0,15ng/mL/cm³
- PSA livre / PSA total -> alterado: < 10-15%
- Velocidade de PSA -> alterado: > 0,75 ng/mL/ano

BIÓPSIA DE PRÓSTATA

INDICAÇÕES DE BIÓPSIA DE PRÓSTATA:
- Toque retal alterado
- PSA ⩾ 4ng/ml
- Densidade de PSA > 0,15ng/mL/cm³ de próstata
- Relação PSA livre/PSA total < 10-15%
- Velocidade de PSA > 0,75ng/mL/ano

O diagnóstico do câncer de próstata é feito por meio de biópsia transretal guiada por ultrassonografia ou ressonância magnética.

ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CaP

ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO

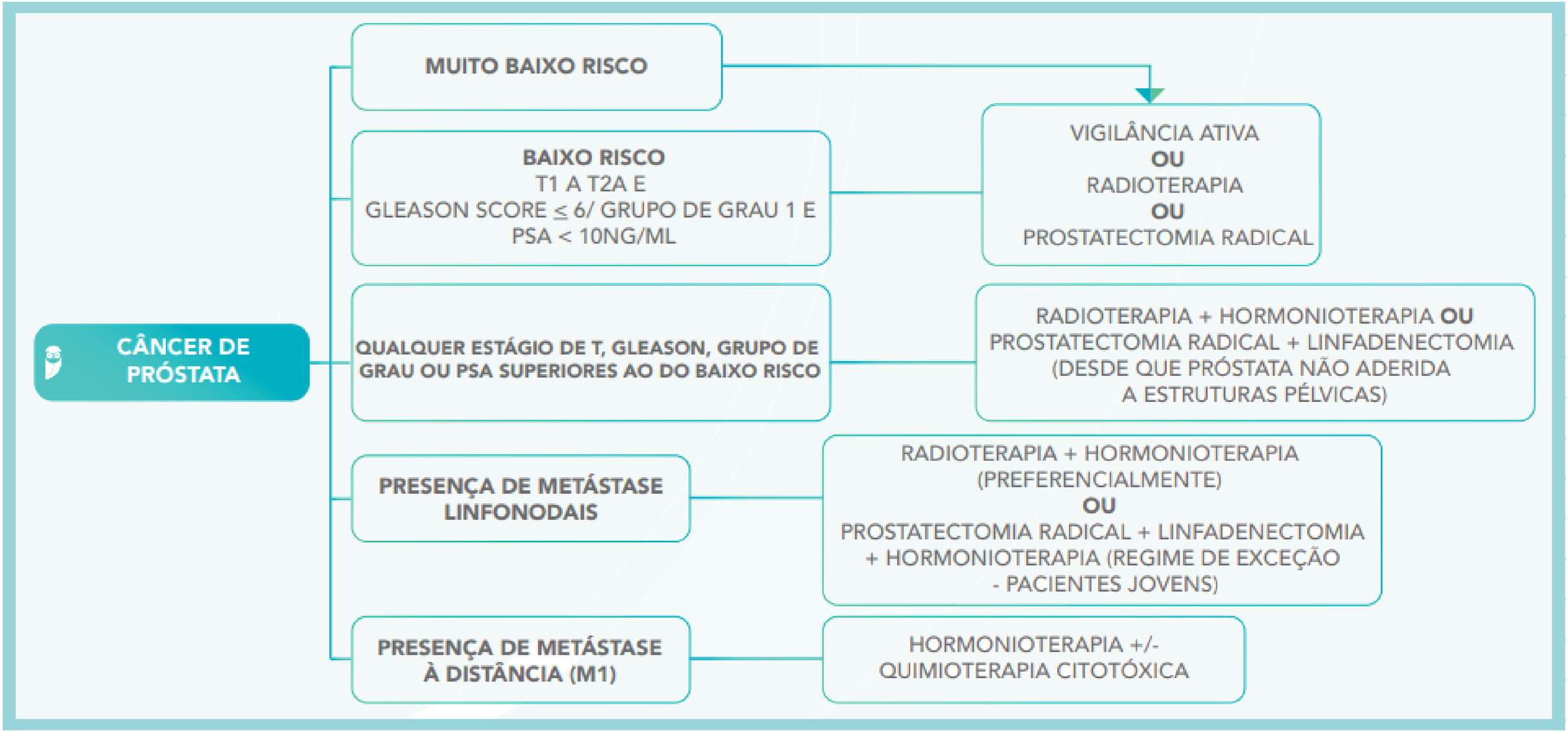
Estratégia MED

Leva em conta: Classificação TNM | PSA | Escore de Gleason | Grupo de grau

RISCO	CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-PATOLÓGICAS
MUITO BAIXO RISCO	• T1CE • ESCORE DE GLEASON ⩽6/GRUPO DE GRAU 1 E • PSA <10 E • MENOS DE 3 FRAGMENTOS POSITIVOS NA BIÓPSIA E • DENSIDADE DE PSA <0.15ng/mL/g.
BAIXO RISCO	• T1 A T2a E • ESCORE DE GLEASON ⩽6/GRUPO DE GRAU 1 E • PSA <10ng/mL E • SEM OUTROS CRITÉRIOS DE MUITO BAIXO RISCO.
RISCO INTERMEDIÁRIO FAVORÁVEL	• T2b A T2c OU • ESCORE DE GLEASON 4+3 = 7/GRUPO DE GRAU 2 OU • ESCORE DE GLEASON 3+4 = 7/GRUPO DE GRAU 3 OU • PSA > 10-20ng/mL E • MENOS DE 50% DE FRAGMENTOS POSITIVOS NA BIÓPSIA.
RISCO INTERMEDIÁRIO DESFAVORÁVEL	• T2b A T2c OU • ESCORE DE GLEASON 4+3 = 7/GRUPO DE GRAU 2 OU • ESCORE DE GLEASON 3+4 = 7/GRUPO DE GRAU 3 OU • PSA >10-20ng/mL.
ALTO RISCO	• T3a OU • ESCORE DE GLEASON 8/GRUPO DE GRAU 4 OU • ESCORE DE GLEASON 4+5 = 9/GRUPO DE GRAU 5 OU • PSA >20 ng/mL.
MUITO ALTO RISCO	• T3b A T4 OU • ESCORE DE GLEASON PREDOMINANTE DE 5 OU • >4 FRAGMENTOS COM GLEASON DE 8 A 10/ GRUPO DE GRAU 4 OU 5.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

FLUXOGRAMA DE TRATAMENTO



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina